

TEMA 3.5 • OBSTETRICIA

Diabetes en el Embarazo — Diagnóstico y Clasificación

PERFIL EUNACOM 2.01.2.004
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Diabetes en el Embarazo — Diagnóstico y Clasificación

Concepto clave: En el embarazo NO existe la prediabetes

En embarazadas, los rangos que en una no-embarazada serían "glicemia de ayuno alterada" o "intolerancia a la glucosa oral", se diagnostican **directamente como diabetes mellitus gestacional (DMG)**.

Diabetes Mellitus Gestacional (DMG)

Definición: Diagnóstico realizado **después de las 12 semanas** de embarazo.

Criterios diagnósticos (cualquiera confirma):

TABLA 3.5.1: CRITERIO VS VALOR	
CRITERIO	VALOR
Glicemia de ayuno (× 2)	≥ 100 mg/dL
TTGO 75g — basal	≥ 100 mg/dL
TTGO 75g — postcarga 2h	≥ 140 mg/dL
Glicemia ≥ 200 + síntomas (> 12 sem)	Confirma DMG

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En embarazo: **glicemia ≥ 100 = DMG directamente** (no "glicemia de ayuno alterada"). No hay prediabetes.

Diabetes Mellitus Pregestacional (DMPG)

Definición: Diagnóstico hecho **antes del embarazo** o en las **primeras 12 semanas**.

Criterios (mismos que en no-embarazada):

TABLA 3.5.2: CRITERIO VS VALOR	
CRITERIO	VALOR
Diagnóstico previo documentado	—
Glicemia de ayuno × 2	≥ 126 mg/dL (en primeras 12 sem)
Glicemia (cualquier hora) + síntomas	≥ 200 mg/dL (en primeras 12 sem)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si los mismos criterios se cumplen **después de las 12 semanas** → es **DMG**, no DMPG.

Screening de Diabetes en el Embarazo

TABLA 3.5.3: MOMENTO VS EXAMEN		
MOMENTO	EXAMEN	RESULTADO → CONDUCTA
Inicio del embarazo	Glicemia de ayuno	< 100: normal → TTGO posterior; ≥ 100: repetir (diagnóstico DMG si se confirma)
24–28 semanas	TTGO 75g	Basal < 100 y postcarga < 140: normal; cualquier valor ≥ umbral → DMG
32–34 semanas (con FR)	TTGO 75g (repetido)	Mismos valores de corte

Factores de riesgo que anticipan TTGO a 32–34 sem: - Feto grande para EG - Polihidramnios - Oligoamnios - DMG en embarazo anterior

Casos Prácticos Tipo EUNACOM

TABLA 3.5.4: GLICEMIA DE AYUNO VS EG			
GLICEMIA DE AYUNO	EG	DIAGNÓSTICO	CONDUCTA
105 mg/dL	Sin embarazo	Glicemia de ayuno alterada	Pedir TTGO
105 mg/dL	8 semanas (< 12 sem)	DMG (no DMPG: no alcanza a 126)	Repetir para confirmar
105 mg/dL	28 semanas	DMG	Repetir/confirmar
130 mg/dL	Sin embarazo	DM (provisional)	Repetir para confirmar
130 mg/dL	8 semanas (< 12 sem)	DMPG (≥ 126, antes de 12 sem)	Repetir para confirmar
130 mg/dL	28 semanas	DMG (> 12 sem = no puede ser DMPG)	Repetir para confirmar
TTGO: basal 105, poscarga 150	Sin embarazo	Glicemia ayuno alterada + intolerancia glucosa oral	Prediabetes

| TTGO: basal 105, poscarga 150 | 8 o 28 semanas | **DMG** | Confirmar |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"En relación a Diabetes en el Embarazo — Diagnóstico y Clasificación: Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) Definición: Diagnóstico realizado después d... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Diabetes en el Embarazo — Diagnóstico y Clasificación. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Concepto clave: En el embarazo NO existe la prediabetes
- Diabetes Mellitus Gestacional (DMG)
- Diabetes Mellitus Pregestacional (DMPG)
- Screening de Diabetes en el Embarazo
- Casos Prácticos Tipo EUNACOM
- directamente como diabetes mellitus gestacional (DMG)
- Diagnóstico realizado

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DIABETES EN EL EMBARAZO — DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN)**PREGUNTA 1**

En relación a Diabetes en el Embarazo — Diagnóstico y Clasificación: Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) Definición: Diagnóstico realizado después d... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Diabetes en el Embarazo — Diagnóstico y Clasificación se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Diabetes en el Embarazo — Diagnóstico y Clasificación debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Diabetes en el Embarazo — Diagnóstico y Clasificación requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Diabetes en el Embarazo — Diagnóstico y Clasificación es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Diabetes en el Embarazo — Diagnóstico y Clasificación no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Diabetes en el Embarazo — Diagnóstico y Clasificación?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Diabetes en el Embarazo — Diagnóstico y Clasificación. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: DIABETES EN EL EMBARAZO — DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN

En embarazadas, los rangos que en una no-embarazada serían "glicemia de ayuno alterada" o "intolerancia a la glucosa oral", se diagnostican directamente como diabetes mellitus gestacional (DMG). ::tip En embarazo: glicemia ≥ 100 = DMG directamente (no "glicemia de ayuno alterada"). No hay prediabetes. :::